妙利散

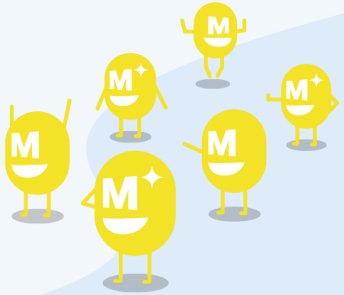
MIYARISAN

全員抵達腸道 發揮作用

©妙利散

內部教育訓練專用，請勿重製

益生菌是指通過改善腸內菌群的平衡來促進維護人體健康的微生物。



活菌

必須是活菌才能夠抑制疾病，對人體或宿主有益。

無毒性

不會致病且無毒性，對人體無任何傷害。

耐胃酸

能夠通過胃酸，穩定於腸道存活、代謝並發揮效用。

安定性強

長期貯存安定性強，功效不受影響

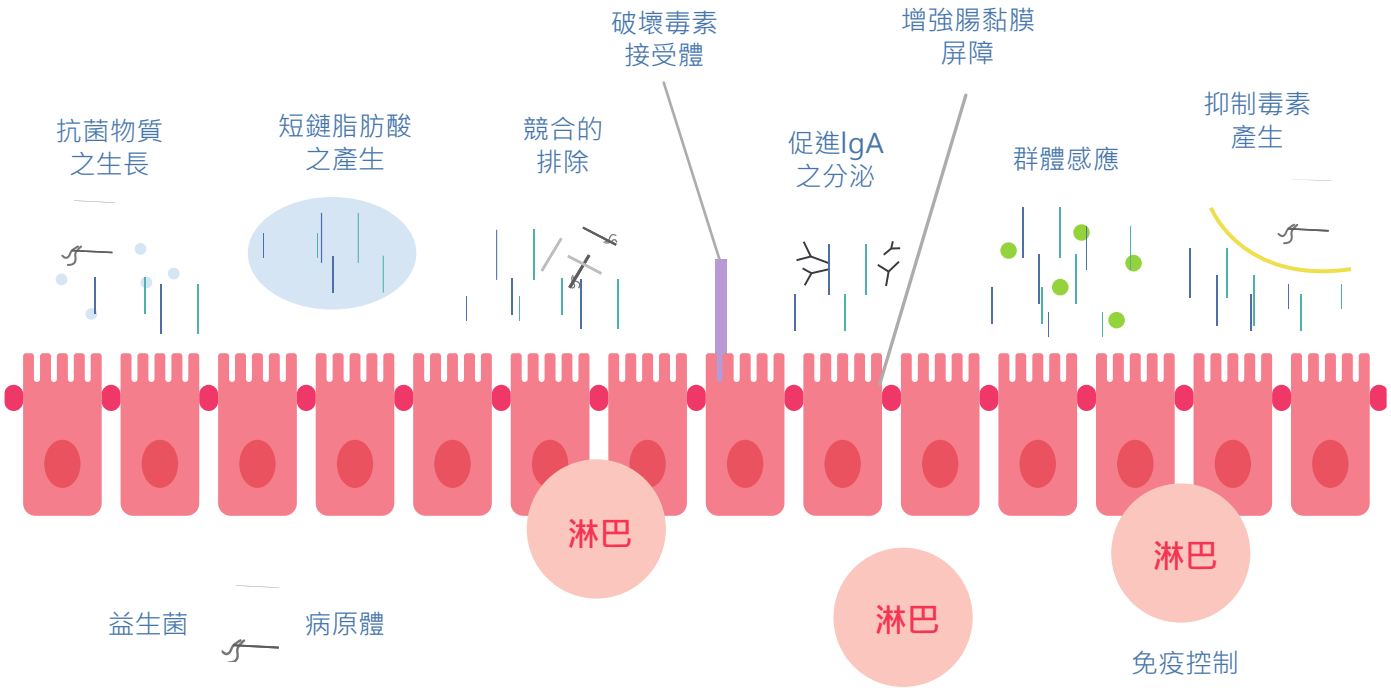
基因穩定

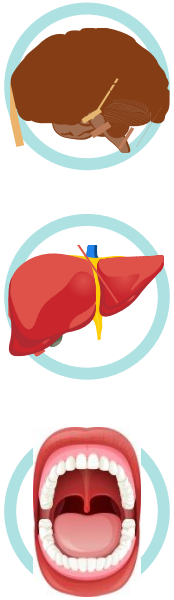
遺傳基因穩定，功效不因遺傳而降低效用

Fuller, 1989

達到上述五點就是好的益生菌

妙利散的作用機轉





Ewaschuk JB. Dieleman LA. World J. Gastorenterol.2006:12(37):5941-50

宮入菌
MIYARISAN 妙利散

未來的明日之星

治療範圍超越胃腸科的益生菌

增強人體免疫力

促進T-reg，調控Th1及Th2，加強人體免疫系統能力。

抗生素輔助治療

能與抗生素併用，緩解其造成腹瀉等症狀。

超越胃腸科應用

過敏、婦科、憂鬱症等皆有醫師廣泛使用。

同步增加AB菌

宮入菌身兼益生源，能幫助其他好菌成長。

	宮入菌	乳酸菌
	耐酸 (pH1.4) 口服後不受胃酸和膽汁酸的影響，以活菌型態至大腸發芽增值	不耐酸 pH3.5以下時活菌幾乎不能生存，極易受到胃酸和膽汁酸影響
能加入牛奶給寶寶食用	耐熱達攝氏55度C	不耐熱 低溫存放
常用於疾病輔助治療	可與抗生素併用	幾乎不可與抗生素併用
	分泌物 ： **酪酸**、乳酸、乙酸 ● 抗潰瘍抗炎症 ●促進水分吸收 (預防腹瀉) ●提高免疫功能 ●抑制毒原性大腸菌的毒素分泌作用優於乳酸 ●提供腸壁細胞能源	分泌物 ：乳酸 不具有酪酸的功能
保存便利	可室溫保存 製劑的穩定性優於乳酸菌	需低溫保存 製劑的穩定性比宮入菌製劑差
幫助其他好菌一起增加	增加體內之A菌B菌繁殖	無
牛奶蛋白過敏患者適用	宮入菌在培養生產工序中，因使用特別生產方法有高收菌率，不須添加脫脂粉乳或蛋白素腺，所以對牛奶蛋白過敏的患者也可以服用。	大部分的乳酸菌和其他酪酸菌在培養等生產工序中，為提高收菌率需添加脫脂粉乳或蛋白腺，所以對牛奶蛋白過敏的患者服用後可能出現腹瀉等過敏症狀。

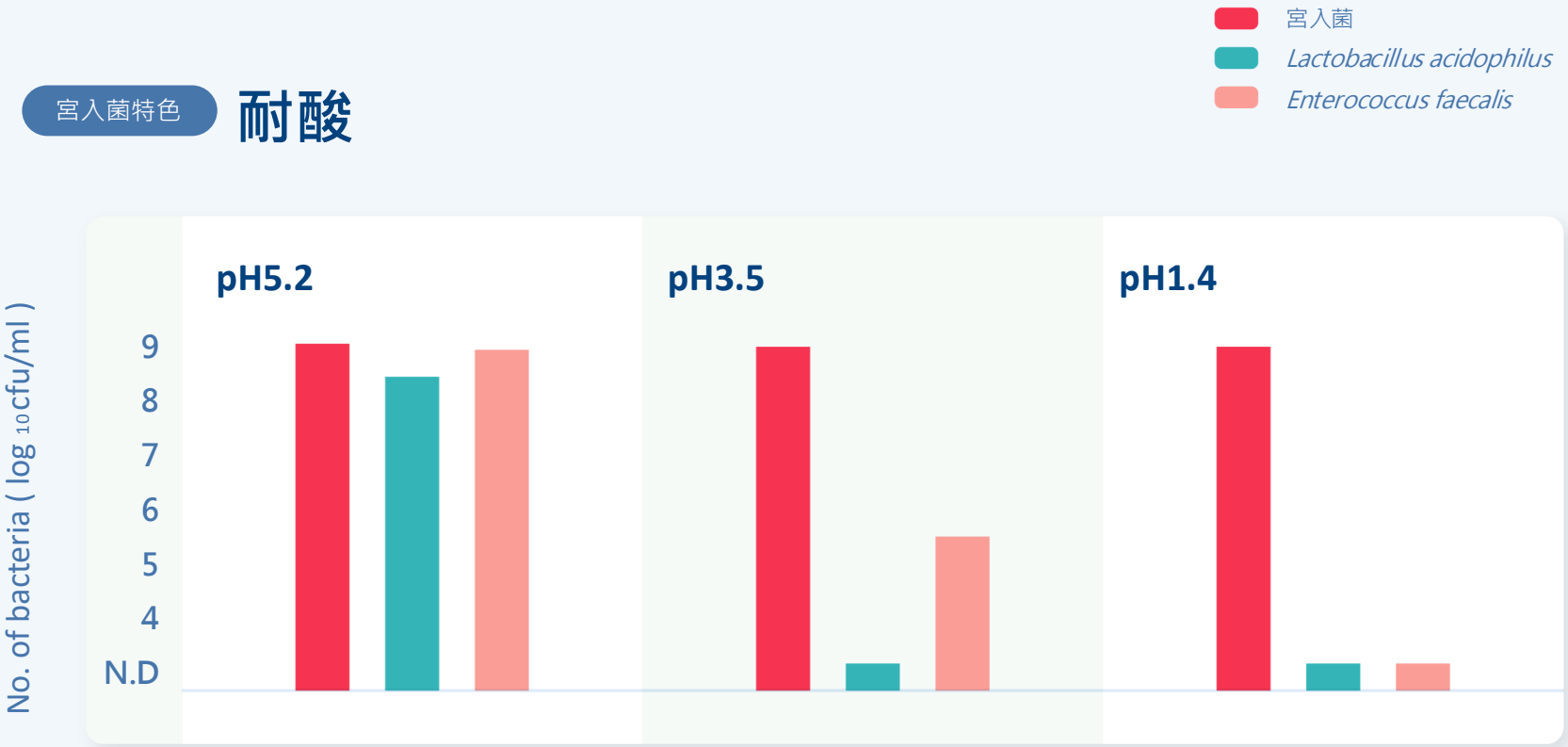
宮入菌特色

芽孢

- 對熱和乾燥具有抵抗力。
- 不受胃酸和膽汁酸影響，以活菌狀態通過胃抵達腸道。
- 不受抗生素影響，可與抗生素併用。

宮入菌特色

耐酸


宮入菌
Lactobacillus acidophilus
Enterococcus faecalis
pH5.2
pH3.5
pH1.4
No. of bacteria (log 10 cfu/ml)
9
8
7
6
5
4
N.D

宮入菌特色

耐熱

Miyarisan Tab. (每Tab.含CBM 588 30mg)
2 Tab : 含 4.0×10^7 之活菌
CBM 588 2 Tab. 宮入菌生菌素之耐熱實驗

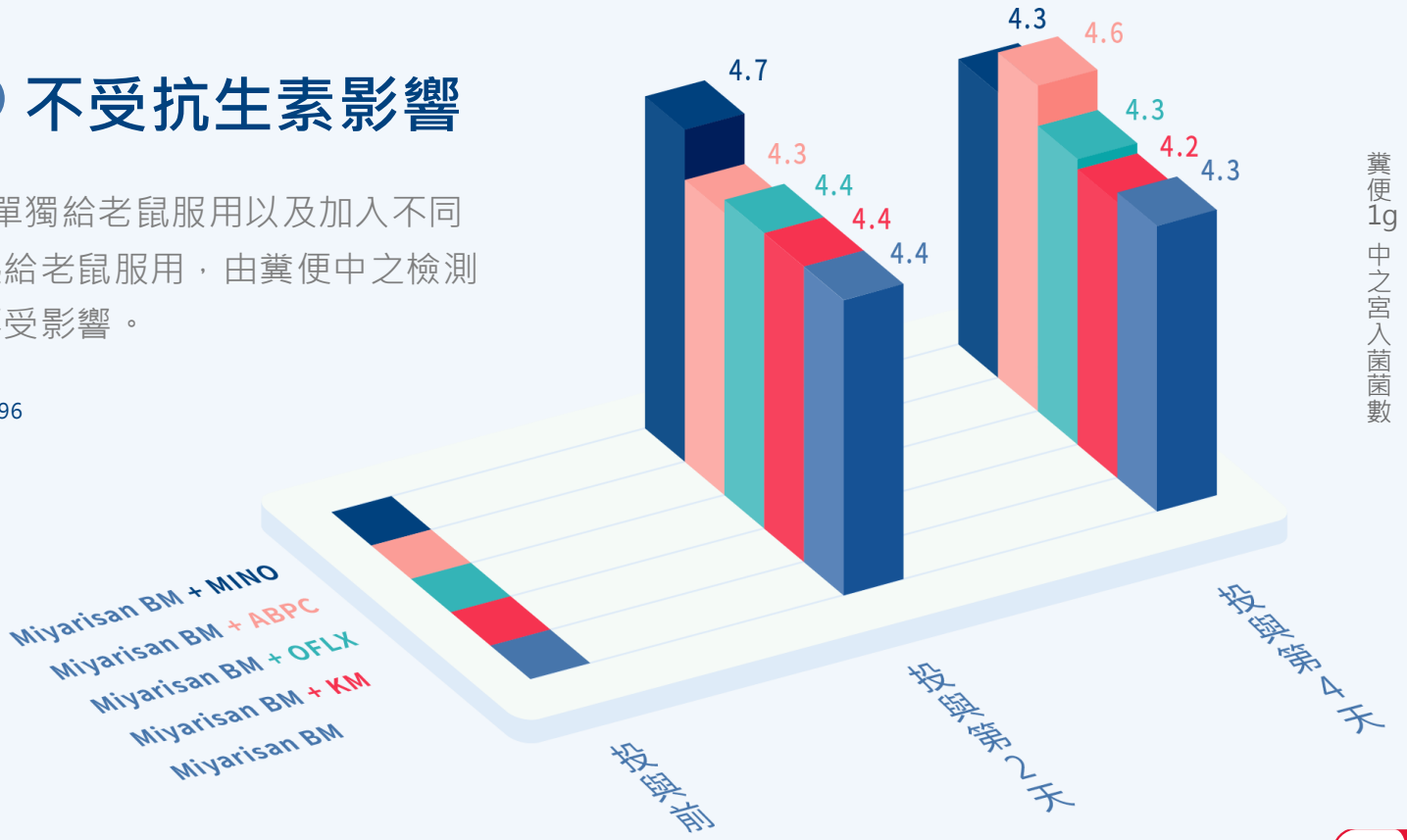
	立刻	10分鐘後	30分鐘後	60分鐘後
常溫水	5×10^7	6×10^7	5×10^7	5×10^7
52 C	5×10^7	5×10^7	5×10^7	4×10^7
55 C	4×10^7	4×10^7	3×10^7	4×10^7

宮入菌特色

不受抗生素影響

妙利散BM單獨給老鼠服用以及加入不同抗生素一起給老鼠服用，由糞便中之檢測宮入菌均不受影響。

Yamazaki et al. 1996



Butyric Acid

酪酸作用

- 保護大腦避免低度發炎
- 促進腸神經系統之健康
- 調節腸粘膜免疫功能
- 提供腸壁細胞能源
- 改善腸管血液循環和蠕動
- 避免腸道發炎和結腸癌

- 止瀉解便秘
- 修復潰瘍
- 抗發炎症狀

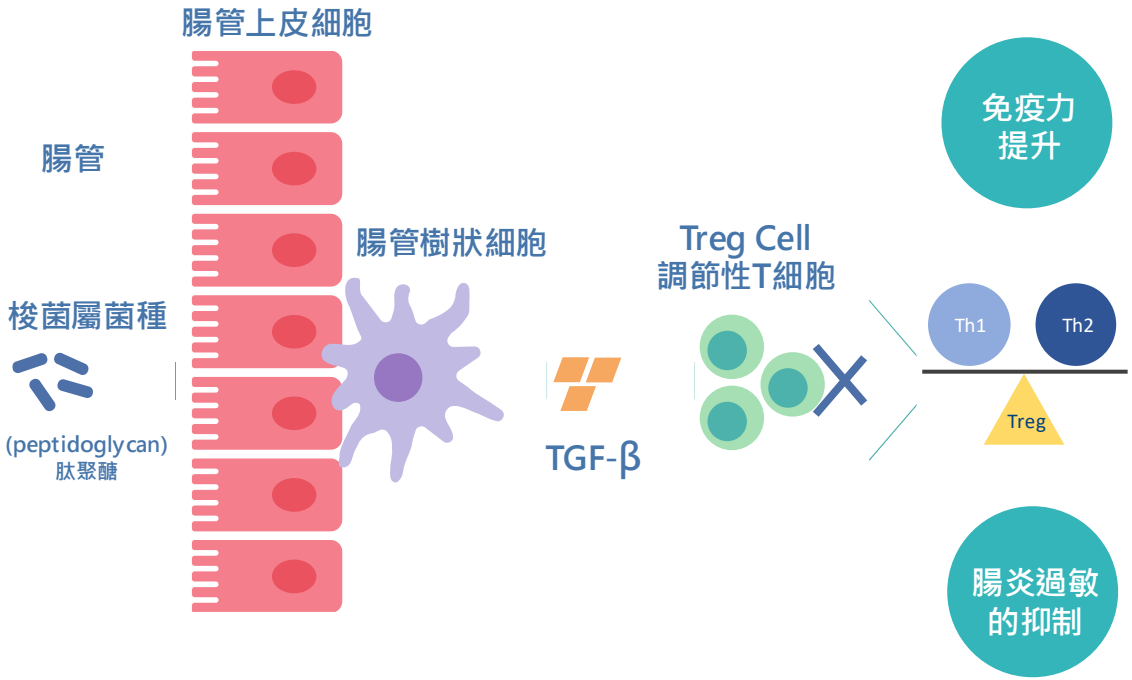
新世代的益生菌

調節免疫

促進T-reg，進而抑制腸道炎症及過敏反應

過敏、異位性皮膚炎、過敏性鼻炎，活性的酪酸益菌的應用範圍倍受期待！

日本慶應大學發表於美國免疫學“Immunity”期刊：酪酸益菌 Miyarisan CBM 588 具有抑制腐敗菌繁殖的功能，進入腸道後，促進分泌具抗炎症作用的蛋白質 (TGF-β)，TGF-β 誘導 Regulatory T-Cell的形成，從而調節緩解因 IgE 分泌旺盛所導致的過敏症狀。因此格外期待 Miyarisan CBM 588 在預防和治療炎症性腸疾病、過敏症的表現。



Kashiwagi et al., 2015, Immunity 43, 65–79

新世代的益生菌

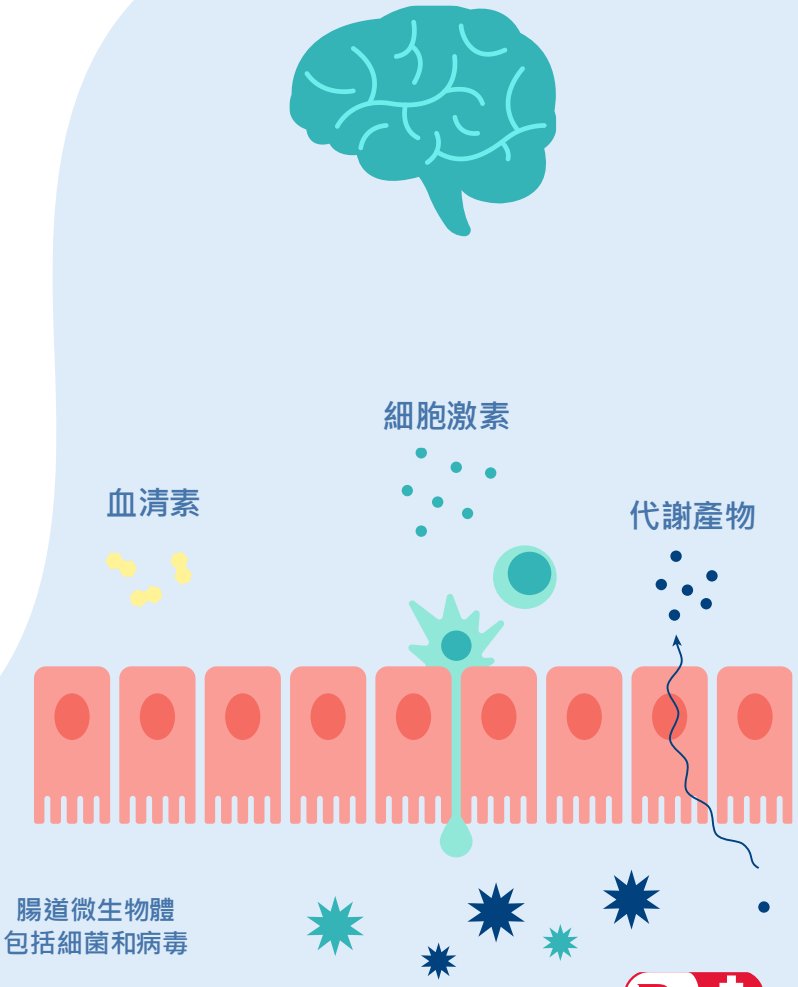
腸腦軸線

宮入菌CBM588 能有效的在「腸-腦軸線」循環中發揮功效可應用在憂鬱症、焦慮症、慢性壓力力治療

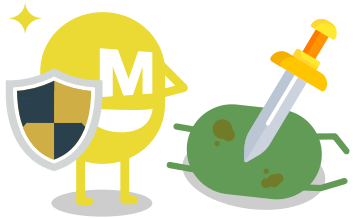
腸不只是消化器官，更被稱為第二個腦。根據研究，腸不只是消化吸收的器官， 也是集結了許多神經與內分泌組織的免疫系統。

另外，腸也會經由向腦部傳達神經訊號，進而影響全身，因此也被稱為第二個腦，對人體來說是非常重要的存在。

而此種腸和腦之間相互傳達訊息的關係即稱為「腸 - 腦軸線」。因此，當腸的狀態絕佳時，腦也會跟著放鬆而一夜好眠；反之，腦感覺緊張時，腸就會感到不舒服而出現腹痛，這就是彼此間相互影響的結果。



人體疾病



消化道

- 病毒感染的腹瀉(輪狀病毒)
- 抗生素造成的腹瀉
- 旅行性腹瀉
- 發炎性腹瀉
  - 潰瘍性大腸炎
- 大腸瘜肉
- 輔助治療
  - 幽門螺旋菌感染
  - 困難梭桿菌感染
- 腸躁症
- 大腸結腸癌

免疫系統

- 增強免疫力
- 類風濕性關節炎

泌尿生殖

- 細菌、白色念珠菌陰道炎

皮膚

- 異位性皮膚炎
- 濕疹

精神疾病

- 憂鬱

肝膽

- 膽囊結石
- 非酒精性脂肪肝
- 非酒精性肝硬化(輕度)

肺臟

- 延長非小細胞肺癌患者生存期
- 延長非小細胞肺癌患者復發進展期

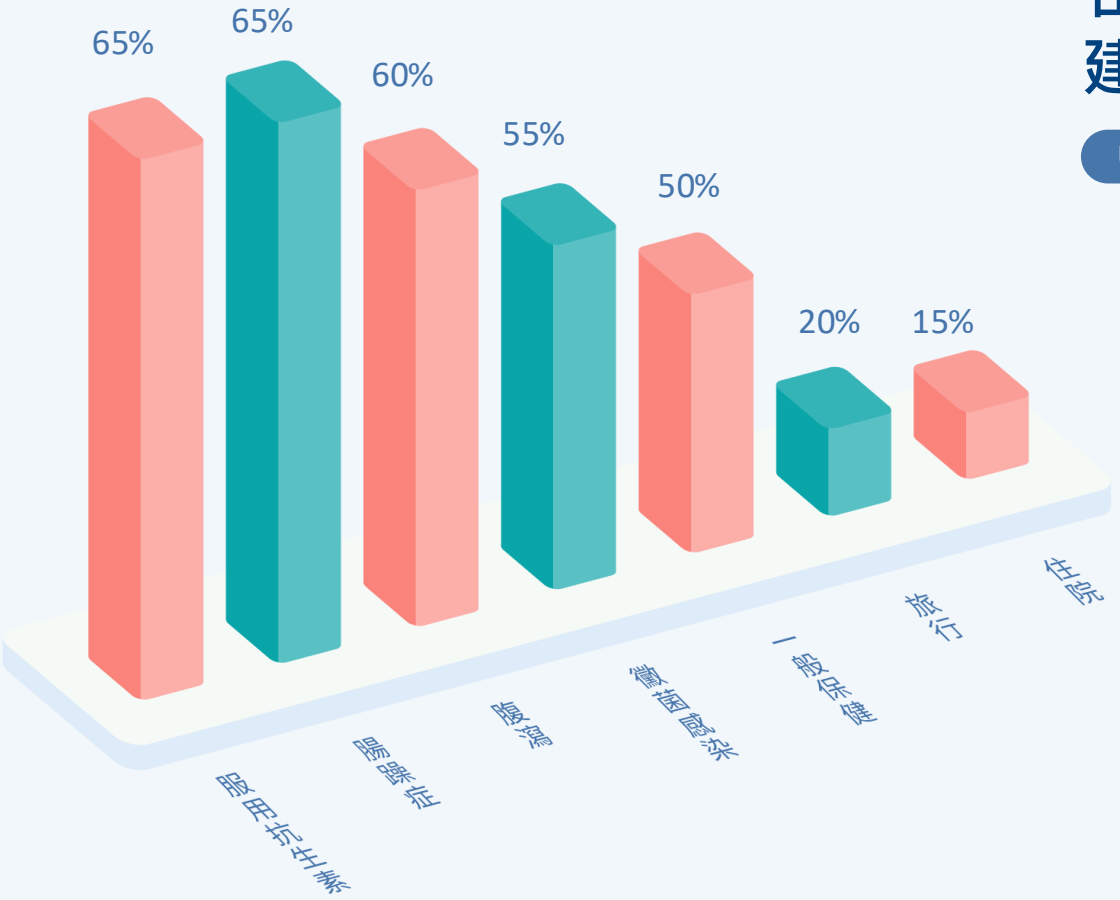
抗生素耐受性

宮入菌對各類代表性抗生素之耐受性之追蹤實驗結果

* 本表所列抗生素經實驗證實均可與宮入菌並用且不會有不良反應

在什麼情況下
建議服用益生菌

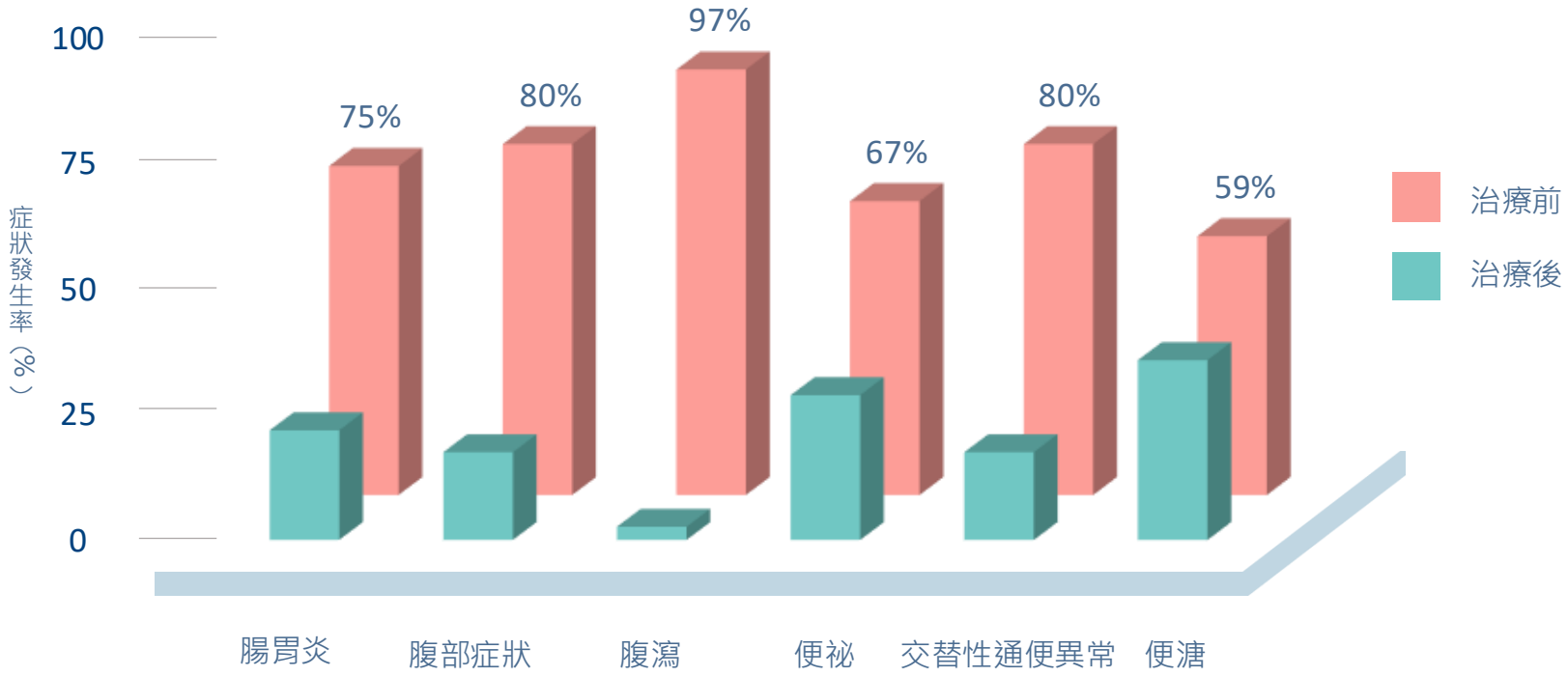
USA 1487位醫師問卷調查



對消化疾病效用實驗（IBD）

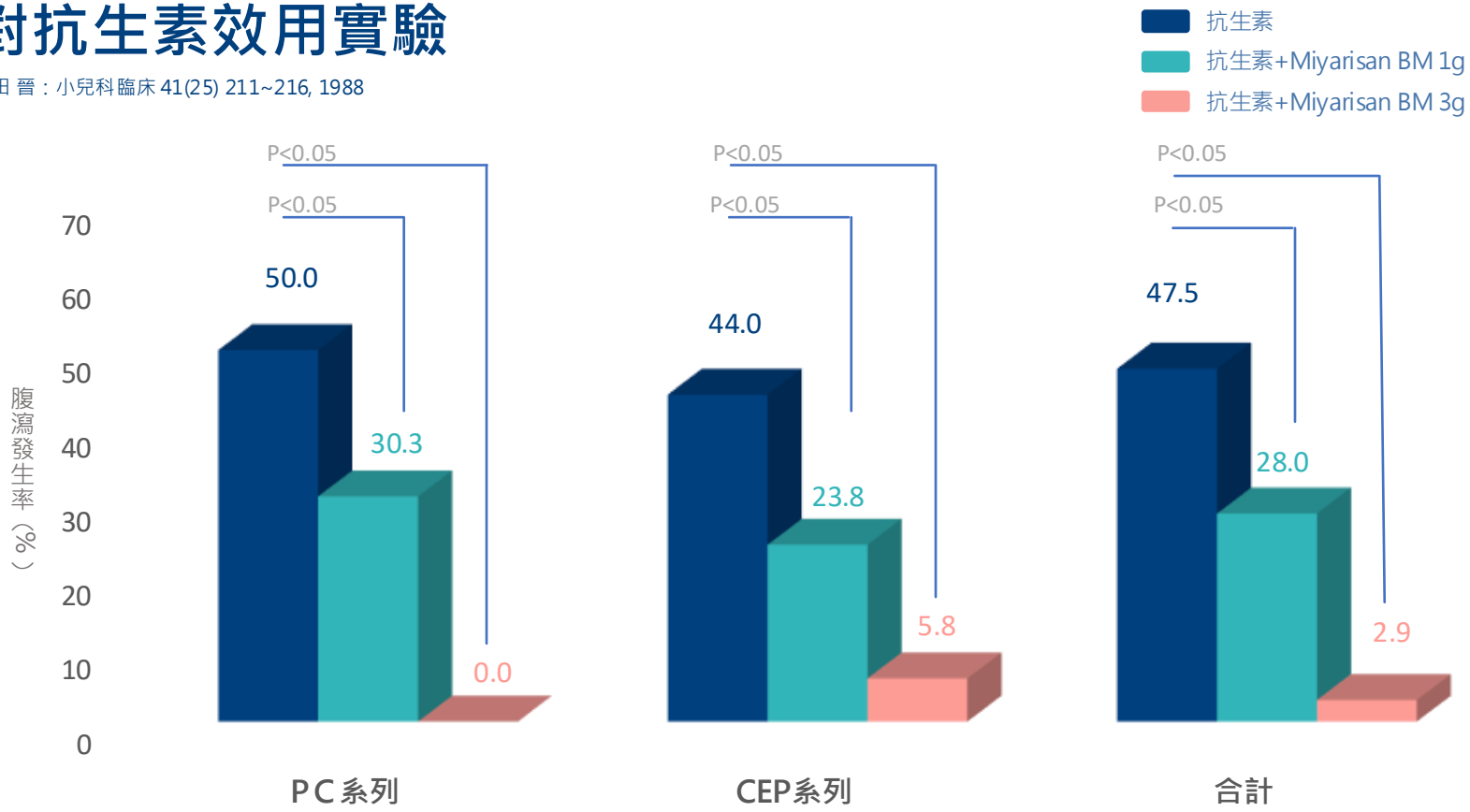
已痊癒人數/受測總人數：499/641=77.8%(治癒率)

武田英二 等:新藥與臨床, 25(9):1505(1976)
岡林一夫 等:新藥與臨床, 43(2):300(1994)
Zhang D.et al.:Chin. J. Gastroenterology, 3(2):82



對抗生素效用實驗

倉田 晉：小兒科臨床 41(25) 211~216, 1988



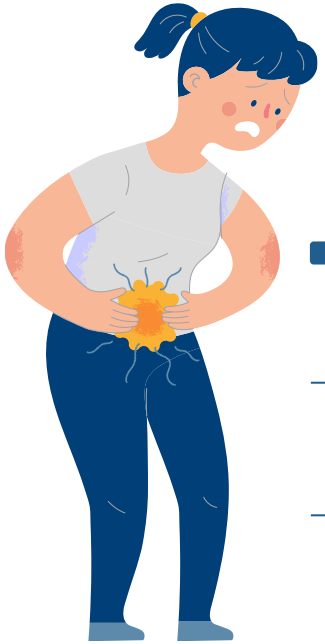
對IBS效用實驗

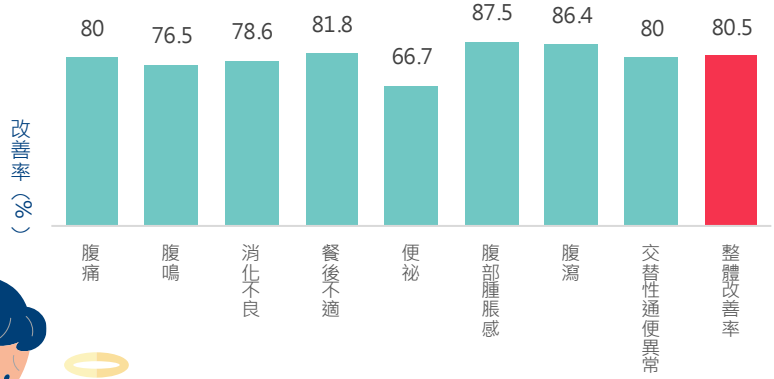
宮入菌對過敏性腸症候群患者腸內菌叢異常之改善效果

Kamiya, S., et al: Review in Medical Microbiology 8. S57-S59. 1997
Zhang D.et al.:Chin. J. Gastroenterology, 3(2):82

菌

健康人(n=30)	患者(n=30) 治療前		治療後
腸桿菌科 *Enterobacteriaceae* 7.34(±0.45)	8.09(±0.49)	▶	7.63(±0.36)
腸球菌 *Enterococci* 4.29(±0.24)	5.51(±0.49)	▶	4.26(±0.34)
梭菌屬 *Clostrisia* 4.38(±0.51)	10.05(±1.21)	▶	4.41(±0.52)
擬桿菌 *Bacteroidaceae* 8.74(±0.63)	9.10(±0.51)	▶	8.40(±0.43)





菌

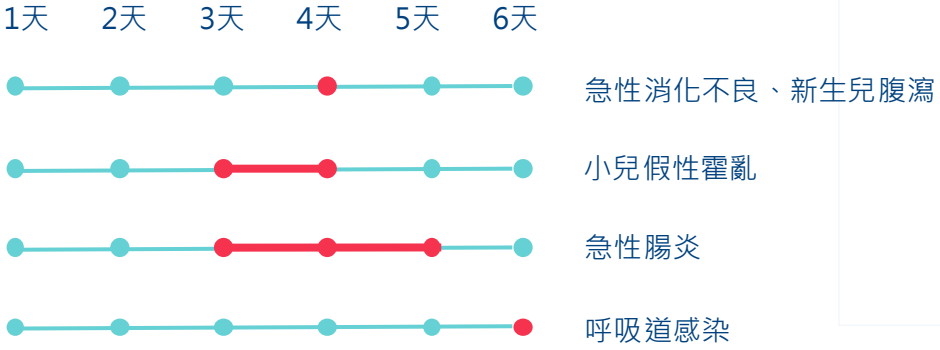
健康人(n=30)	患者(n=30) 治療前		治療後
乳桿菌 *Lactobacilli* 7.79(±0.75)	6.55(±0.98)	▶	8.37(±0.36)
雙歧桿菌 *Bifidobacteria* 9.04(±0.56)	4.79(±1.08)	▶	9.26(±0.41)
總厭氧菌 11.79(±0.51)	9.15(±0.51)	▶	11.47(±0.54)

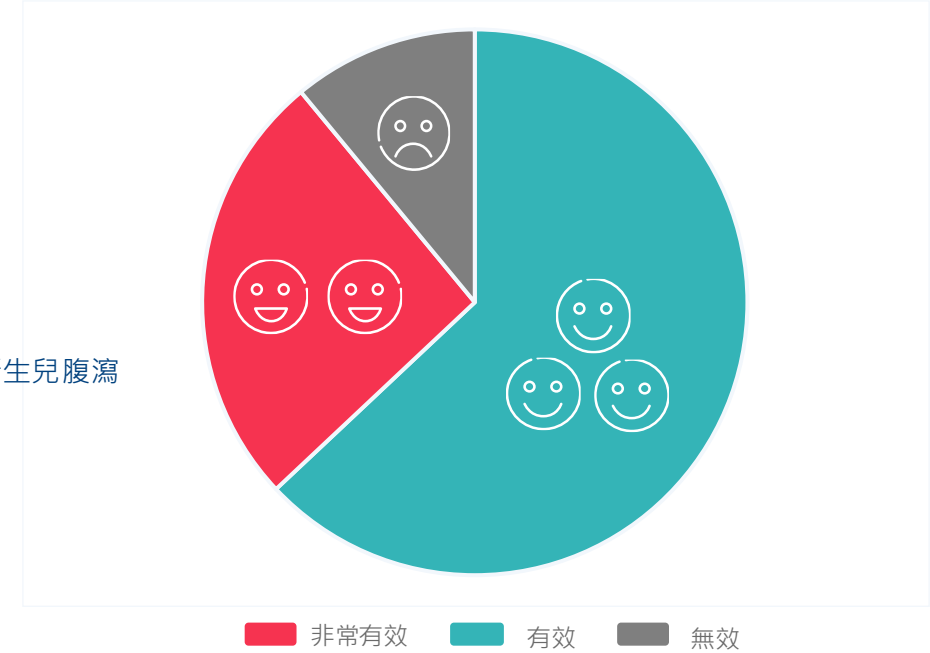
受測人數：123人

對嬰幼兒效用實驗

治療 - Miyarisan BM合併抗生素

症狀改善





樣本：本實驗共60人,年齡範圍為5天～8歲
症狀：腹瀉、腸炎、呼吸道感染
劑量：依症狀不同每日0.5-1.5gm (Miyarisan gm/天)， 7~14天
武田英二，日本德島大學

腹瀉療效高達89.3%

促進乳酸菌增加

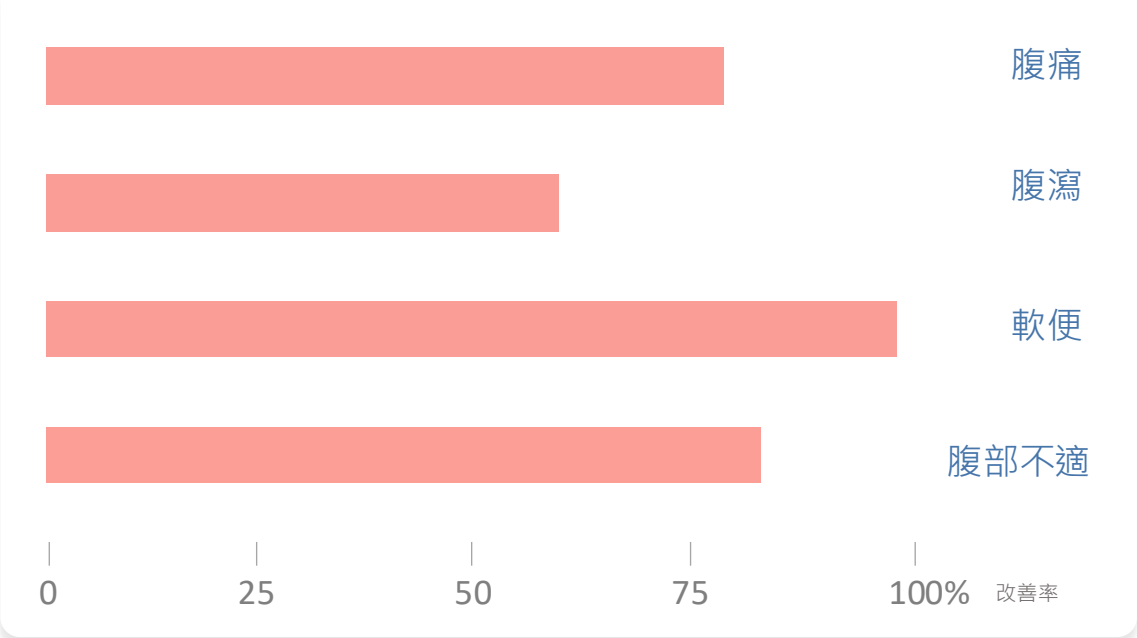
大腸菌及腸球菌等有害菌減少,腸道菌群趨於健康。

呼吸道感染改善達100%

排出之糞便改善無惡化，對腹瀉有預防性效果。

對高齡者效用實驗

受測者各項腸胃不適使用妙利散後的變化



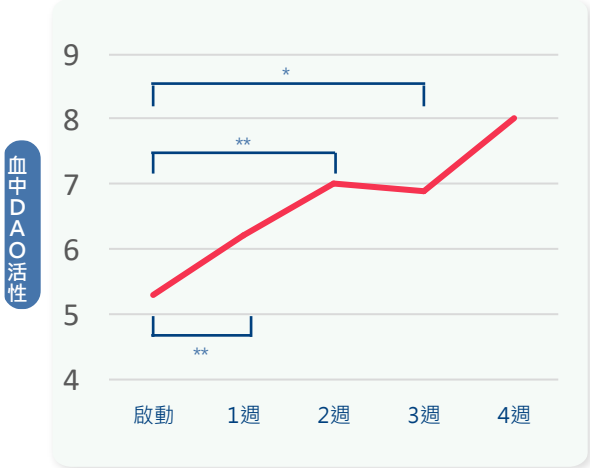
治療後

1994-1995日本琉球大學醫學部研究

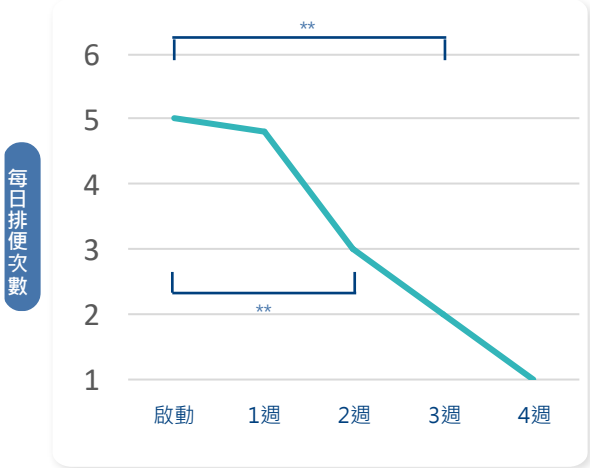
MIYARISAN對高齡鼻胃管患者效用實驗

1997 名古屋大大學醫學部老年年科研究

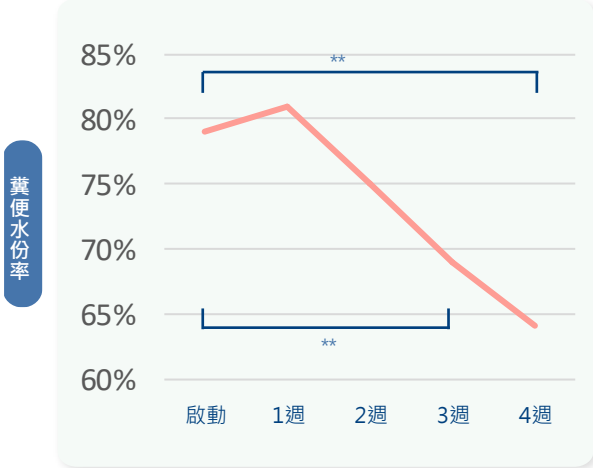
Izumi Ito, et al: Jpn J Geritat 1997; 34: 298-304



* : p<0.05 ** : p<0.01
mean ± S.E.



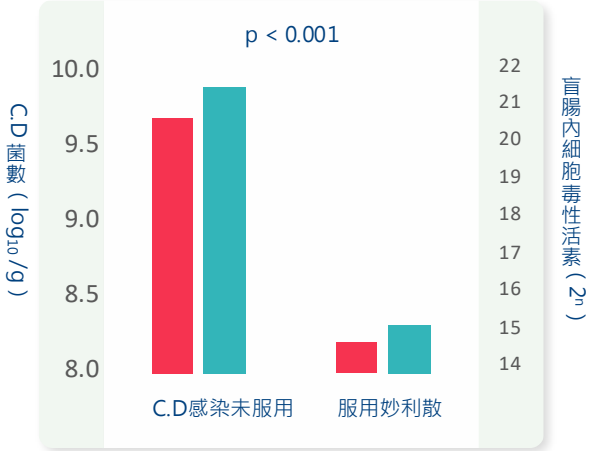
** : p<0.01
mean ± S.E.



** : p<0.01
mean ± S.E.

MIYARISAN 對壞菌患者效用實驗

抑制C.D困難梭菌毒素比較表

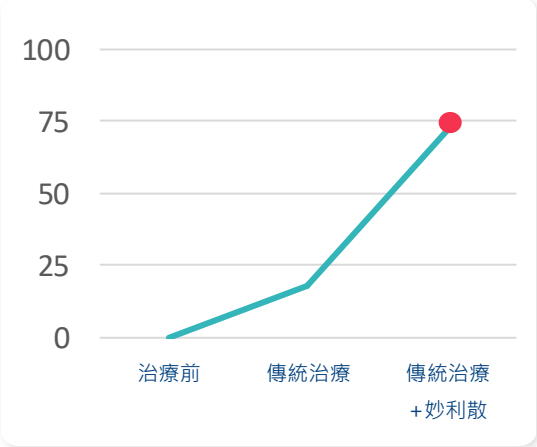


- 可以抑制C.D繁殖之速度
- 可以抑制C.D產生之毒素量
- 可以產生抗毒素之抗體

C.D菌數
毒素量

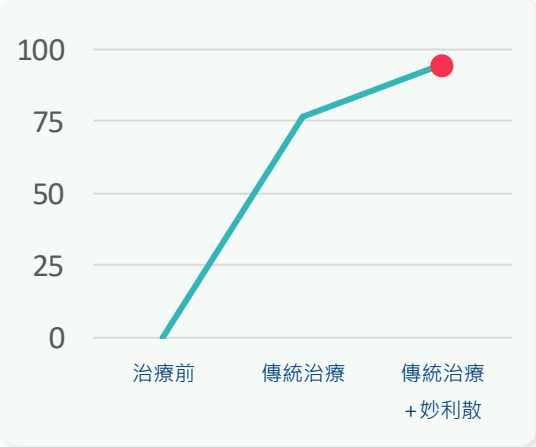
Kamiya, S., et al: Review in Medical Microbiology 8. S57-S59. 1997

腹部不適症改善率變化



- 傳統治療後，僅 17.6% 患者改善
- 傳統治療+MIYARISAN 治療後，有高達 72.2% 的患者有改善

幽門螺旋桿菌除菌率變化



- 傳統治療後，有 76.5% 除菌率
- 傳統治療+MIYARISAN 治療後，高達 94.4% 的除菌率

Simbo I. et al. World J Gastroenterology 2005. 11(47):7520-24

宮入菌的歷史

1933年，宮入近治博士發現了*Clostridium Butyricum* MIYAIRI 588株 (簡稱CBM，日文稱宮入菌)。此菌具有芽孢，屬酪酸菌，有很強的抑制腐敗菌並有促進腸道內有益菌增值的作用。

Miyarisan製藥株式會社專利發明

「 酪酸菌 (*Clostridium Butyricum* 588) 的細菌素 (Bacteriocin) 之遺傳因子排列及其蛋白質 」此專利內容說明*Clostridium Butyricum* 588分泌的細菌素 (Bacteriocin)具有其特有的遺傳因子排列。